

KC桌面——外资精译

波士顿咨询：医生不是成本难题，而是医院控费真正引擎

医疗系统长期面临一个结构性矛盾：既要保证临床质量，又要应对持续的成本不确定性。波士顿咨询在一份最新研究中指出，多数医院将控费重点放在行政开支、非临床人力等“可控”领域，却忽视了临床相关支出——这一块通常占运营总成本的30%到40%。问题不在于缺乏降本空间，而在于变革路径本身。波士顿咨询认为，真正能撬动临床成本优化的杠杆，是医生。

临床成本为什么总是“看得见、够不着”

医院在临床采购上的支出，很大程度受医生偏好、供应商关系和历史惯例影响。波士顿咨询发现，许多机构要么没有让医生参与成本管理，要么在方案成型后才临时拉医生“过场”。结果，医生把成本举措视为行政指令而非临床决策，信任难以建立，目标难以对齐。即便有明确的宏观环境机会，也往往因为组织缺乏变革能力而搁浅。波士顿咨询强调，问题不是“不知道改什么”，而是“不知道怎么改”。

把成本管理重新定义为临床战略

波士顿咨询提出，领先机构的做法是：不把第三方支出当作采购问题，而是当作临床和战略议题。从项目启动之初，临床、运营和管理层就共同确立原则——临床结果不可妥协，差异化产品在影响疗效时保留，只有临床等效的产品才考虑整合。成本改善不是目标本身，而是更优决策和更紧密协作的副产品。波士顿咨询指出，当成本管理被定位为支持增长、技术采纳和临床创新的手段，而非单纯的削减，医生更容易形成共识。

> KC评论：这其实是在说，医院控费不能只靠采购部门压价，而是要把医生从“成本的对立面”拉到“成本决策的参与者”位置。对医疗设备和耗材企业来说，这意味着未来销售策略不能只搞定采购，还要能向临床团队讲清楚产品价值。

医生参与不是一次会议，而是一套机制

波士顿咨询认为，医生参与的关键不是“早”，而是“持续”。在成功案例中，医院会识别受尊重的医生领袖作为变革推动者，让医生在决策前就参与定义等效标准、评估替代方案。医生还能利用与供应商的长期关系，在谈判中传递组织对合作和价值的期望。波士顿咨询建议，医院应建立专门的医生讨论平台，定期分享定价数据、采购规模和财务背景，让医生从临床和机构双重角度评估选择。变革不是一次性事件，而是通过会议、工作坊和一对一沟通维持的持续过程。

波士顿咨询引用一家医院的实践：针对医生偏好物品（如手术植入物和生物制剂）发起结构化招标，不是作为采购活动，而是作为医生主导的变革管理载体。临床团队与供应链人员配对谈判，避免单一供应商依赖，同时保留差异化产品的选择权。结果，此前同类成本项目仅带来边际改善，而这次实现了显著的成本节约和运营提升，更重要的是建立了一套可复用的变革模式。

> KC评论：对医院管理者而言，这份报告的核心启示是：医生不是成本难题的障碍，而是解决方案的引擎。真正可持续的成本优化，不是靠更狠的砍价，而是靠更聪明的临床参与。